GUIA EDUCATIVO

Guia dos Peptídeos

o que a ciência mostra

10 peptídeos que estão em alta, explicados sem hype: o que são, como agem, o que os estudos mostram de verdade, os riscos conhecidos e o status nos EUA e no Brasil.

COMO USAR ESTE GUIA

Leia, entenda e leve suas dúvidas para o seu médico. Este material **não traz doses, protocolos nem indicação de uso** — de propósito.

POR

Maxwell Obolari

@obolari_academy

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

O que é, afinal, um peptídeo?

Peptídeos são **cadeias curtas de aminoácidos** — os mesmos blocos que formam as proteínas, só que menores. No corpo, muitos funcionam como **mensageiros**: encaixam em receptores e dão ordens às células (liberar um hormônio, sinalizar saciedade, reparar um tecido).

AMINOÁCIDO

1 bloco

A unidade básica, como uma letra.

PEPTÍDEO

Poucos blocos

Uma palavra: curta e com uma mensagem específica.

PROTEÍNA

Muitos blocos

Uma frase longa, com estrutura e função mais complexas.

Por que todo mundo está falando disso?

Porque alguns peptídeos viraram remédios com resultados grandes e comprovados — como a semaglutida e a tirzepatida. O problema é que esse sucesso fez **dezenas de outros peptídeos**, com muito menos estudo, serem vendidos na internet como se fossem iguais. Não são.

ATENÇÃO

"Ser natural do corpo" não significa "ser seguro em qualquer quantidade". E "funcionou em ratos" não significa "funciona em pessoas".

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

Como ler a evidência em 30 segundos

Antes de acreditar em qualquer promessa, pergunte: **em quem isso foi estudado?** Neste guia, cada peptídeo tem um selo de evidência:

SELO	O QUE SIGNIFICA
FORTE	Grandes estudos em humanos (fase 3), com milhares de pessoas, e aprovação de agências como a FDA (EUA) ou a Anvisa (Brasil).
MODERADA	Estudos em humanos, mas para um grupo específico, em menor número ou ainda em análise pelas agências.
INICIAL	Poucos estudos pequenos em humanos; a maior parte vem de laboratório e animais.
FRACA	Praticamente só estudos em células e animais. Benefício e segurança em pessoas não estão estabelecidos.

4 perguntas que separam ciência de propaganda

1

Foi testado em **humanos** ou só em animais?

2

Quantas pessoas e **por quanto tempo**?

3

Comparou com **placebo**?

4

Alguma agência **aprovou** — e para quê?

PARTE 2 · METABOLISMO E PESO

Os remédios que mudaram o tratamento da obesidade

FORTE

Semaglutida

O QUE É	Imita o GLP-1, hormônio do intestino que aumenta a saciedade e ajuda a controlar a glicose.
ESTUDOS	No estudo STEP-1, perda média de cerca de 15% do peso em 68 semanas. No SELECT, menos eventos cardiovasculares em pessoas com doença cardíaca.
RISCOS	Náusea, vômito, alterações intestinais; raramente pancreatite e problemas de vesícula.
STATUS	Aprovada pela FDA e pela Anvisa (diabetes tipo 2 e obesidade).

FORTE

Tirzepatida

O QUE É	Age em dois hormônios ao mesmo tempo: GIP e GLP-1.
ESTUDOS	SURMOUNT-1: cerca de 21% de perda média em 72 semanas (sem diabetes). SURMOUNT-2: cerca de 15% em quem tem diabetes tipo 2.
RISCOS	Parecidos com os da semaglutida, principalmente gastrointestinais.
STATUS	Aprovada pela FDA e pela Anvisa.

MODERADA

Retatrutida

O QUE É	"Agonista triplo": GIP, GLP-1 e glucagon.
ESTUDOS	Fase 2 (NEJM, 2023) com perda média de até cerca de 24% em 48 semanas. Estudos de fase 3 em andamento.
RISCOS	Gastrointestinais e aumento da frequência cardíaca nos estudos; perfil de longo prazo ainda em estudo.
STATUS	Investigacional: ainda não aprovada pela FDA nem pela Anvisa.

MODERADA

Cagrilintida + semaglutida (CagriSema)

O QUE É	Combina a semaglutida com uma versão de longa duração da amilina, hormônio da saciedade do pâncreas.
ESTUDOS	REDEFINE 1: perda média de cerca de 20% em 68 semanas. Num estudo direto, não mostrou ser tão eficaz quanto a tirzepatida.
RISCOS	Principalmente náusea e vômito.
STATUS	Em análise na FDA; não aprovada no Brasil.

PARTE 2 · GORDURA, DESEJO E RECUPERAÇÃO

Os que estão em alta nas redes sociais

MODERADA

Tesamorelina

O QUE É	Imita o hormônio do cérebro que faz a hipófise liberar hormônio do crescimento.
ESTUDOS	Reduziu em média cerca de 15% da gordura visceral em 6 meses, em pessoas com HIV e gordura abdominal acumulada.
RISCOS	Inchaço, dor nas articulações, aumento da glicose; a gordura tende a voltar ao parar.
STATUS	Aprovada pela FDA só para esse grupo. Consulte o status atual na Anvisa.

MODERADA

PT-141 (bremelanotida)

O QUE É	Age no sistema da melanocortina, em áreas do cérebro ligadas ao desejo sexual.
ESTUDOS	Aprovada em 2019 nos EUA para mulheres antes da menopausa com desejo baixo persistente. Em homens, evidência fraca.
RISCOS	Náusea em cerca de 4 em cada 10 mulheres nos estudos; aumento passageiro da pressão.
STATUS	FDA: aprovada só nesse caso. Brasil: sem registro localizado na Anvisa.

FRACA

BPC-157

O QUE É	Fragmento derivado de uma proteína do suco gástrico, estudado para cicatrização.
ESTUDOS	Quase tudo em animais e células. Dados em humanos são mínimos.
RISCOS	Desconhecidos em pessoas. A FDA o listou entre substâncias com possíveis riscos para uso em manipulação.
STATUS	Não aprovado como medicamento. Proibido no esporte (WADA).

FRACA

TB-500

O QUE É	Fragmento sintético da timosina beta-4, proteína ligada à migração de células e reparo.
ESTUDOS	Principalmente em animais e laboratório.
RISCOS	Segurança em humanos não estabelecida.
STATUS	Não aprovado como medicamento. Proibido no esporte (WADA).

PARTE 2 · PELE E LONGEVIDADE

Os queridinhos da longevidade

INICIAL

GHK-Cu

O QUE É Tripeptídeo ligado ao cobre, presente naturalmente no sangue; o nível cai com a idade.

ESTUDOS Em uso tópico (cremes), há estudos pequenos sugerindo melhora de colágeno e textura da pele. Para uso injetável, faltam dados em humanos.

STATUS Usado em cosméticos; não é medicamento aprovado.

FRACA

MOTS-c

O QUE É Peptídeo produzido pelas próprias mitocôndrias, apelidado de "exercício em frasco".

ESTUDOS Em camundongos: melhor resposta à insulina e mais desempenho em animais idosos. Em humanos: o exercício aumenta o MOTS-c do próprio corpo; não há estudo completo com aplicação.

STATUS Não aprovado como medicamento.

Resumo do guia

PEPTÍDEO	EVIDÊNCIA	FDA (EUA)	ANVISA (BR)
Semaglutida	FORTE	Aprovada	Aprovada
Tirzepatida	FORTE	Aprovada	Aprovada
Retatrutida	MODERADA	Em estudo	Não aprovada
CagriSema	MODERADA	Em análise	Não aprovada
Tesamorelina	MODERADA	Aprovada (grupo específico)	Consultar
PT-141	MODERADA	Aprovada (grupo específico)	Sem registro localizado
GHK-Cu	INICIAL	Cosmético	Cosmético
BPC-157 · TB-500 · MOTS-c	FRACA	Não aprovados	Não aprovados

Status verificado em novembro de 2026. Regras mudam: confira sempre nas fontes oficiais (fda.gov e gov.br/anvisa).

PARTE 3 · ANTES DE QUALQUER DECISÃO

Leve estas perguntas ao seu médico

- Para o meu objetivo, existe tratamento com evidência **forte** e aprovado?
- Quais exames eu deveria fazer antes de pensar em qualquer tratamento?
- Com a minha saúde e os remédios que já uso, quais riscos são maiores para mim?
- O que dá para fazer primeiro com sono, alimentação e treino?
- Como vamos acompanhar o resultado — e quando faz sentido parar?

SINAIS DE ALERTA

Desconfie quando aparecer:

"Só para pesquisa"
Produto vendido com esse rótulo não é medicamento e não tem garantia de conteúdo.

Promessa de resultado rápido
"Perca X kg em Y dias" é marketing, não ciência.

Venda sem receita
Remédio sério exige avaliação e acompanhamento.

"Zero efeitos colaterais"
Tudo que tem efeito pode ter efeito colateral.

CONTINUE APRENDENDO

Ciência, sem hype

Toda semana eu explico um peptídeo, vitamina ou tema de longevidade no Instagram — o que é, o que os estudos mostram e o que ainda não se sabe.

ME CONTA LÁ NOS COMENTÁRIOS

Qual peptídeo você quer que eu explique no próximo vídeo?

@obolari_academy

AVISO IMPORTANTE

Este guia tem caráter exclusivamente educativo. **Não é recomendação médica nem sugestão de uso** de qualquer substância, e não substitui consulta com profissional de saúde. Fontes: estudos publicados (NEJM, The Lancet, PubMed) e informações oficiais da FDA e da Anvisa, consultadas em novembro de 2026.